

署長出席【天下雜誌 115 年 7 月 26 日閉門專家會議】

消失的生命時差

從華人好發癌別，看健康台灣如何加速癌症治療接軌國際

【鈞長參與與談環節 1】14:10~15:00 (50min)

落實健康平權：以病人為中心，加速華人好發癌別新藥可及

■ 01 | 看見疾病負擔與病人處境：

華人好發癌別的臨床挑戰、未滿足需求與生命時差

■ 02 | 辨識結構性治療落差：

全球研究資源錯配、市場規模限制與國際指引落差

■ 03 | 重新定義治療價值：

從延長存活，擴大至功能保留、生活品質與重返社會

■ 04 | 以病人需求重塑決策：

納入病人證據、落實病友參與和「好藥先用」

■ 05 | 建立差異化加速路徑：

以疾病負擔為優先，推動分流審查、HTA 與健保給付協作

※ 本署負責回應之題綱：05 | 建立差異化加速路徑：

➤ 制度解方 | 陳亮好署長

Q： 為使健保資源配置更貼近國人的實際健康需求，健保署未來是否可建立一套綜合考量國內疾病負擔、未滿足醫療需求、過早死亡、族群代表性及臨床效益的優先評估原則，讓不同癌別皆能依其疾病特性與病人需求，獲得適切的給付評估與政策優先序？

針對已納入國際治療指引、臨床效益明確，且能回應重大未滿足需求的創新療法，對於具族群特異性癌別，政府可如何整合藥證審查（含新增適應症）、HTA 與健保給付流程，並運用平行送審、條件式給付、風險分攤及真實世界資料再評估，建立明確、可預期且具效率的差異化優先評估路徑，讓具實質臨床價值的創新治療更及時惠及病人？

本署擬答

為達到總統「健康台灣推動委員會」在 2030 年達成癌症標準化死亡率降低三分之一之目標，將全面落實「癌症治療三箭」策略—提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、並建立百億癌症新藥基金，持續增加健保新醫療科技預算，並透過「平行送審」與「暫時性支付」等機制加速癌症新藥收載，強化醫療科技評估量能並成立「國家醫療科技評估中心」，建立高效且具科學實證基礎的健保給付政策。

114 年癌症醫療花費為 1,566 億元，癌藥費用支出為 495.5 億元，占 32%，106-114 癌藥費用平均成長率為 9.3%。

近年癌藥預算、品項及受惠人數逐年增加，收載情形如下表：

年度	癌症新藥及擴增給付合計項數	受惠人數(人)
112	19	4,500
113	27	13,950
114	36	10,960
115 (1-7 月)	20	20,100

一、新藥預算逐年增加

(一) **新醫療科技預算**：本署持續爭取新藥相關預算，113 年健保總額藥品新醫療科技、給付規定改變及暫時性支付專款預算編列共計 60.49 億元，約為 112 年的兩倍；而自 114 年起，除健保總額內預算外，亦已公務預算挹注 50 億元設立之「癌症新藥暫時性支付專款」，新藥相關預算約 101.27 億元，突破百億規模，115 年亦較 114 年微幅成長達約 104.38 億元。

(二) **公務預算挹注癌症新藥暫時性支付專款(癌症新藥基金)**：

1. 114、115 年皆由公務預算挹注 50 億元進全民健康保險基金，逐步達百億規模，且持續爭取明年預算，其指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，針對成本效益不明確之癌症新藥或新適應症，先用專款收載 2-3 年，後續再依實證銜接常規健保給付，以緩解病人藥品自費之負擔。
2. 截至 115 年 7 月「癌症新藥暫時性支付專款」已收載 8 項新藥及 3 項擴增給付，用於治療兒童癌症、非小細胞肺癌、乳癌、大腸直腸癌及多發性骨髓瘤等病人，受惠人數約 3,500 人，其中 8 項為食藥署查驗

登記加速核准案件，且其中 6 項於英國、加拿大及澳洲等三大 HTA 組織並未皆建議收載，健保給付早於十國。

二、 加速新藥收載機制

(一)平行送審機制

1. 為加速收載未滿足醫療需求(Unmet Medical Need)之藥品，於自 113 年 1 月 1 日起建立平行送審機制，新藥自取得藥證至健保收載中位數約 9.5 個月(最短約 3.5 個月)。
2. 截至 115 年 7 月，已有 6 項生效給付，治療癌別包含多發性骨髓瘤(MM)如 Elrexfio (elranatamab)藥品人年藥費 526.5 萬元、瀰漫性大型 B 細胞淋巴瘤(DLBCL)如 Minjuvi (tafasitamab)藥品人年藥費 192 萬元、急性骨髓性白血病(AML)如 Vanflyta (quizartinib)藥品人年藥費 85 萬元、慢性骨髓性白血病(CML)如 Bostini (bosutinib)藥品人年藥費 52.4 萬元、非小細胞肺癌(NSCLC)如 Augtyro (repotrectinib)藥品人年藥費 147 萬元及胃腺癌(GC)如 Vyloy (zolbetuximab)藥品人年藥費 178 萬元。

(二)暫時性支付：

1. **癌症新藥暫時性支付：**配合國家癌症防治政策，擴大新藥預算來源，政府自 2025 年起以公務預算挹注 50 億元設立「癌症新藥暫時性支付專款」。透過暫時性支付專款機制，可加速具臨床實證效益並獲國際治療指引(如 NCCN)推薦的新藥及早提供病人使用，改善過去受健保總額預算限制而延後給付的情形。
2. **非癌症新藥暫時性支付：**於健保總額內亦設有「暫時性支付專款」，針對具高度醫療需求但仍存在部分不確定性的創新藥品，提供先行納入給付的機制。

(三) 癌症治療接軌國際：

1. 參考美國國家癌症資訊網 (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 指引。目前肺癌已 100%接軌、乳癌 95%、大腸直腸癌也已補足第一線到第四線之治療缺口。
2. 後續刻正逐步盤點卵巢癌、食道癌、胰臟癌、前列腺癌、胃癌等癌別之治療，以嘉惠更多癌友。

三、 落實以病患為中心之理念，推動品質提升照護模式：

- (一) 健保制度正逐步自「論量計酬」轉型為「論質計酬」。鑑於近年乳癌發生率攀升，健保署於現有之乳癌醫療給付改善 (P4P) 方案基礎上，自 115 年 1

月起新增「乳癌照護品質提升方案」，目標將全國 80%新確診乳癌病人納入醫療照護體系。

- (二) 藉由「新收個案」與「追蹤照護」獎勵，鼓勵醫院收案管理照護並登錄個案資料，以建置全國基準數據，並規劃導入「價值導向給付」分級獎勵機制，鼓勵醫院提升照護品質。

四、推動「行政法人國家醫療科技評估中心」，強化醫療科技評估量能：健保署持續擴大推動我國醫療科技評估量能，建立以實證與成本效益為基礎之健保藥品收載決策模式，並規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心，相關設置條例(草案)經行政院 114 年 12 月 11 日院會決議通過，函送立法院審議中（已於 115 年 7 月 1 日完成黨團協商，待二、三讀）。

【鈞長參與與談環節 2】15:20~16:10 (50min)

化支出為投資：建構差異化創新路徑，落實 2030 降癌目標

聚焦三大主軸：

■ **01 | 財務毒性對臨床照護的挑戰**

病人能否及時開始、持續並完成治療

■ **02 | 政策資源轉換效率：**

預算如何更快、更精準地轉化為病人受益

■ **03 | 將醫療支出轉化為健康投資：**

衡量健康餘命、功能、家庭韌性與社會回報

※ 本署負責綜合回應與政策行動方向 | 陳亮好署長

Q：

■ **提升基金資源的轉換效率**

依健保署資料，114 年度癌症新藥基金編列 50 億元，累計至 114 年第 4 季使用約 13.27 億元，顯示基金仍保有相當的政策運用空間。

在兼顧財務紀律、臨床實證與基金永續的前提下，健保署未來可如何透過滾動式檢討與更具彈性的資源配置機制，優先回應已完成第三期臨床試驗、療效明確，且具高疾病負擔、治療選擇有限及重大未滿足醫療需求的創新療法，特別是華人好發癌別的新藥或新增適應症？又應如何在加速收載、治療平權與基金永續之間取得平衡，讓政策資源更及時轉化為病人的治療機會？

■ **建立以病人整體價值為核心的成果評估**

WHO《2026 年全球癌症現況報告》強調，癌症照護的價值應從降低死亡率與延長存活，進一步擴大至健康餘命、功能保存與生活品質。

未來健保署在評估癌症新藥基金與創新治療的政策成效時，除了預算執行率與實際受惠人數外，可如何逐步納入縮短給付等待時間、延長健康餘命、維持生活功能、改善生活品質及降低治療中斷等價值導向成果指標？

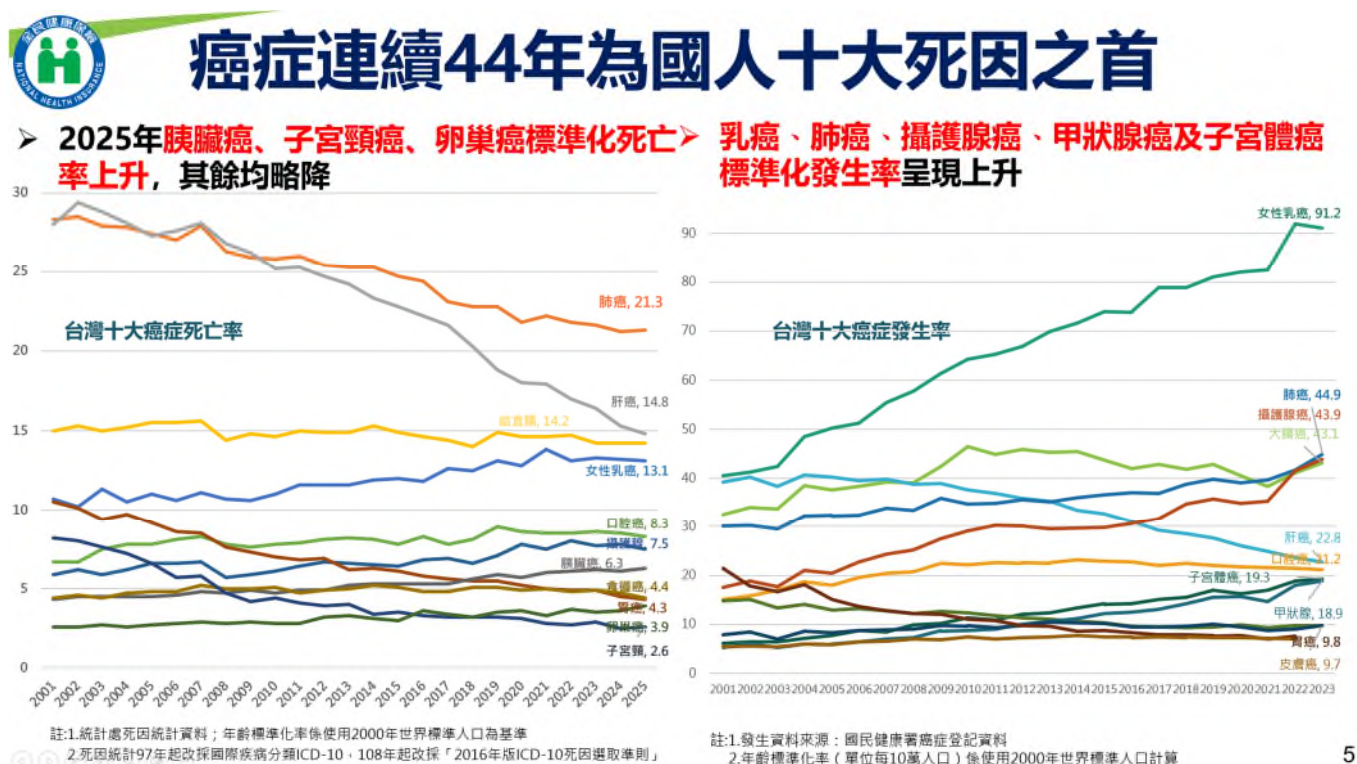
在制度設計上，又可如何結合 HTA、給付後真實世界資料與定期再評估，建立一套從「資源投入—治療可近—病人受益—健康成果」的完整追蹤機制？

本署擬答

健保的給付須兼顧病人需求與制度永續；健保署將持續透過科學實證評估各項癌症治療的給付項目，讓有限資源發揮最大效益。並運用數據分析結合臨床專業，強化資訊化整合，建立以病人為中心的全人照護模式。。

一、2024 年攝護腺癌、卵巢癌標準化死亡率上升，其餘癌別均下降：

透過癌症發生率及死亡率數據了解國人癌症疾病負擔，並藉由前瞻性評估（HS）、醫療科技評估（HTA）及醫療科技再評估（HTR），增加新藥預算，持續提升民眾用藥可近性，同時透過收集到的真實世界數據，可以了解藥品的實際治療效益與財務衝擊，轉銜常規健保並納入病友意見，從共擬會議至專家會議，經再評估接軌健保給付。目前 19 項暫時性支付之癌症藥品，其中 1 項(轉移性之非小細胞肺癌(NSCLC)藥品之 TEPMETKO(tepotinib)已轉至一般健保支付，其他藥品(如：治療白血病之 CAR-T 及 Blincyto)刻正陸續檢討評估。



二、推動癌症全人照護推動癌症治療數位轉型

(一) 建構一致性資料交換格式: 健保署積極導入快速醫療照護互通資源 (Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR)，整合檢測與審查流程。目前正建置大腸直腸癌等五癌之事前審查檢核規則，以期

加速審查效率，讓民眾能及早用藥。

- (二) **跨司署整合病人照護歷程**：目前已串聯國健署篩檢及健保署申報資料，建置篩檢陽性個案照護歷程儀表板。現已完成大腸癌及乳癌。以大腸癌為例，114 年針對篩檢陽性未確診 22%(19,523 人)及高風險未治療 7%(2,838 人)個案回饋院所以進行追蹤。未來此數位監測模式將擴大至肺癌、口腔癌及子宮頸癌，並主動產出未確診、未治療名單供院所追蹤，並規劃結合「健康存摺」推播提醒病友回診，落實各期程之照護。
- (三) **落實以病患為中心之理念**：健保制度正逐步自「論量計酬」轉型為「論質計酬」。鑑於近年乳癌發生率攀升，健保署於現有之乳癌醫療給付改善(P4P)方案基礎上，自 115 年 1 月起新增「乳癌照護品質提升方案」，目標將全國 80%新確診乳癌病人納入醫療照護體系。實施初期適度放寬參與資格，藉由「新收個案」與「追蹤照護」獎勵，鼓勵醫院收案管理照護並登錄個案資料，以建置全國基準數據；待資料建置穩定後，將規劃導入「價值導向給付」分級獎勵機制，鼓勵醫院提升照護品質。

【備參數據】

一、健保藥品新藥預算逐年增加

(一)114年藥品相關預算共約101.27億元：包含總額內新醫療科技25.41億元、藥品給付規定範圍改變20.86億元及非癌藥之暫時性支付專款5億元，共51.27億元，加上總額外以公務預算挹注50億元設立之「癌症新藥暫時性支付專款」(癌症新藥基金)達101.27億元。

(二)115年藥品相關預算共約104.38億元：包括總額內新醫療科技25.59億元、藥品給付規定範圍改變24.29億元及非癌藥之暫時性支付專款4.5億元，共54.38億元，加上總額外再以公務預算挹注50億元至「癌症新藥暫時性支付專款」，預估約達104.38億元，相較於114年提升3%，期望能嘉惠更多病人，減輕負擔。

(三)新藥給付情形：

115年截至7月1日生效，健保已給付癌症新藥9項及擴增給付11項，受惠人數約為20,100人

➤ 112年-115年7月收載情形

年度	112 年				113 年			
	新藥(項)	擴增給付(項)	合計	受惠人數(人)	新藥(項)	擴增給付(項)	合計	受惠人數(人)
癌藥	8	11	19	4,500	9	18	27	13,950
罕藥	10	1	11	716	6	2	8	930
其他新藥	13	11	24	246,000	16	11	27	86,000

	114 年				115 年截至 7 月			
	新藥(項)	擴增給付(項)	合計	受惠人數(人)	新藥(項)	擴增給付(項)	合計	受惠人數(人)
癌藥	20	16	36	10,960	9 (暫支 1 項)	11	20	20,100
罕藥	9	-	9	638	2	4	6	480
其他新藥	8	22	30	1,051,000	7 (暫支 1 項)	8	15	56,600

二、食道癌藥品收載情形(截至115年7月)(附圖)

(一)已給付1項標靶藥物(trastuzumab)、1項免疫檢查點抑制劑(nivolumab)及多項化療藥物(如：docetaxel)，預估受惠人數約941人，藥費約7.19億元，財務影響約5.89億元（尚未扣除協議還款）。

(二)審查中1項：tislelizumab 建議用於先前接受含鉑化學治療後疾病惡化，無法手術切除之局部晚期或轉移性食道鱗狀細胞癌(ESCC)，且腫瘤表現PD-L1 $\geq$ 1%之成人病人，刻正審議中。

(三)標靶藥物及免疫檢查點抑制藥品之受惠人數及推估財務如下：

藥品名	給付範圍	受惠 病人數	藥費 (億元)	藥費財務影響 (億元)
Trastuzumab (如 Herceptin) (109/2/1)	適用於未曾接受過化學治療之HER2 過度表現(IHC3+或FISH+)轉移性胃腺癌(或胃食道接合處腺癌)的治療。	100	0.58	0.58
Nivolumab (如 Opdivo) (113/4/1)	曾接受合併含鉑及fluoropyrimidine 化學治療之後惡化的無法切除晚期或復發性食道鱗狀細胞癌病人。	326	1.38	1.38
Nivolumab (如 Opdivo) (115/2/1)	用於無法接受化學放射性治療或手術切除等治癒性治療之晚期或轉移性食道鱗狀細胞癌成人病人的 <u>第一線治療</u> 。	515	5.23	3.93

三、鼻咽癌藥品收載情形(截至115年7月)

經查現行健保給付中無用於治療鼻咽癌之標靶及免疫檢查點抑制劑，而免疫檢查點抑制劑具有頭頸部鱗狀細胞癌之許可適應症，惟查藥品仿單其臨床試驗並未納入鼻咽癌患者，無法確認對於鼻咽癌族群之療效，爰現行免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定將鼻咽癌排除。倘未來有許可適應症廠商檢具臨床實證向本署建議納入給付，本署將依程序辦理。

四、癌症新藥暫時性支付專款預估使用情形

癌症新藥暫時性支付專款預估使用情形

製表日期2026/07/24

	癌藥基金 累計預算 (億元)	累計(推估) 使用藥費 (億元)	累計執行率
114年	50	13.0	26%
115年	100	95.0	95%

備註：

✓ 累積(推估)使用藥費：

若當年度有實際藥費以實際藥費計算，若無則以各項目HTA預估年度藥費(未扣除協議還款)。

